EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 85123
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-23 11:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RUPERTO ORTEGA ORTEGA			RUN	: 4.491.778-5
F.Nac	: 23-05-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 23-05-2024	Fecha Egreso	: 2024-05-23 11:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico fronto-opérculo-parieto-insular izquierdo, etiología obs cardioembólico
-Neumonía aspirativa basal derecha, ATB 2/7
-EAOC EEII
-Deshidratación leve
-Ant: HTA - ICC - Demencia severa (3 años) - Postración severa (3 meses) - Amaurosis bilateral (ptisis bulbi OD y catarata OI) - Disfagia (desde abril/24) - mRS 5 (dependencia completa) - Desnutrición severa
-Fcos: digoxina 0.25 mg Lu-Dom, FSD 20 mg/d, AAS 100 mg/d, memantina, quetiapina 100 mg/n, citalopram 20 mg/d

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente en malas condiciones generales, HDN estable, RS al monitor, eupneico, afebril, tolera bien alimentación por SNG, confuso, somnoliento, sin tos. Estable en déficit neurológico inicial (hemiparesia BC derecha), quejumbroso.
TC cerebro s/c muestra infarto agudo fronto-opérculo-parieto-insular izquierdo sin TH, y secuelas isquémicas occipital izquierda, fronto-insular derecha, parietal derecha, talámico izquierdo y cerebeloso derecho; atrofia cerebral difusa severa.
Rx tórax muestra consolidación pulmonar basal y porción media derechas.
Exs de laboratorio destaca elevación de troponinas, PCR, GB, uremia y Na, esto último sugerente de deshidratación.
Paciente con enfermedad neurodegenerativa avanzada, dependiente completo y desnutrición severa, cursando con ACV de posible origen cardioembólico y neumonía aspirativa sin repercusión cardiopulmonar.
Por condición actual no es candidato para DAPT o anticoagulación por alto riesgo hemorrágico y pérdida completa de funcionalidad desde al menos 3 meses, por lo que desestimo completar estudio con angioTC cerebro y cuello, ETT y Holter de ritmo.
Ajusto tto crónico, se suspende FSD, AAS, quetiapina y memantina; disminuyo dosis de digoxina e inicio cilostazol, LST y ATV.
En acuerdo con hija se decide alta a domicilio hoy, IC HODOM para completar tto ATB empírico por 7 días por neumonía aspirativa (se desestima realizar CSB, HC y urocultivo) y continuar con KNTM y Fonoaudiología rehabilitatorias, y control ambulatorio en policlínico de Neurología.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-IC HODOM para completar tto ATB por 7 días por neumonía aspirativa y continuar con KNTM y Fonoaudiología

rehabilitatorias
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología
-Ingesta de agua por SNG 300 cc 4v/d

INDICACIONES AL ALTA

1. -Cilostazol 100 mg c/12 horas
2. -Digoxina 0.25 mg 1/2 comp lunes-miercoles-viernes
3. -Atorvastatina 40 mg/noche
4. -Ceftriaxona 2g/d EV por 6 días
5. -Ipratropio 2 puff c/6 horas por 7 días, c/aerocámara
6. -Losartan 50 mg 1/2 comp al día
7. -Cloranfenicol colirio 2 gotas c/6h en ojo izquierdo por 7 días
8. -Cloranfenicol ungüento 1v/noche en ojo izquierdo por 7 días

EXÁMENES Y RESULTADOS

22/5/24
-Crea 1 MDRD 71.19 Uremia 82
-FA 84 BI 0.45 BD 0.35 BT 0.8 GOT 18 GPT 17 GGT 33
-CKMB 7 CK 54
-Lact 1.2
-PCR 180.7
-Na 148 K 4.1 Cl 117
-INR 1.34 TTPA 30
-Trop 242.2
-Hb 10.3 Leu 15100 Plaq 285000 Seg 93
-Influenza A/B(-)
-COVID(-)

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión N, mucosa oral seca, yug no ing, rash(-), sarcopenia severa, contractura las 4 EE (> en EEII) y rigidez cervical, ptisis bulbi OD y catarata+pannus corneal OI, secreción conjuntival purulenta ojo izquierdo
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BD, dolor difuso leve al tacto, Blumberg(-), RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos pedios muy disminuidos o no palpables, llene capilar <2s, frialdad distal a izquierda

Ex neurológico:
-Mental: somnoliento, confusión severa, no emite lenguaje ni sigue órdenes, resto n/e
-PC: CV n/e por amaurosis bilateral, ptisis bulbi OD, pupila OI midriática y arreflectica, ROC OI impresionan conservados, PFC der moderada, disartria n/e, sensibilidad facial algésica conservada con maniobra de Foix, atonía mandibular, nistagmo(+) vertical descendente OI, úvula y lengua centrales, resto n/e
-Motor: ESI M4-5, ESD M2, EEII M2, RCP extensor bilateral, espasticidad BC izquierda, hipotonía BC derecha
-Sensibilidad: algesia impresiona conservada en ambos hemicuerpos y cara
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO